三、辅助检查

肺结核和肺炎本质都是肺部感染,诊断思路一致:有无肺结核→确诊肺结核病原体

（一）影像学检查

X 线是肺结核的常规首选，可进一步 **CT** 检查

1.抓住 ttsx 继发性肺结核的好发部位：**上叶尖后段、下叶背段和后基底段**（勾肩搭背 hou 基友）

注意：合并AIDS的患者免疫力低下→传播途径更类似原发性肺结核(主要经淋巴道和血道播散)→重力原因,下叶血液更丰富→好发于下叶

①艾滋病合并结核好发于**下**叶

②原发性肺结核好发于：**上叶下部、下叶上部近胸膜处**，**肺门淋巴结肿大（原发综合征哑铃状影）**

VS结节病双侧肺门淋巴结肿大

单侧

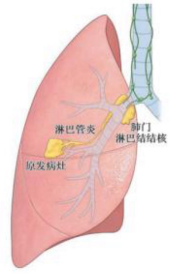
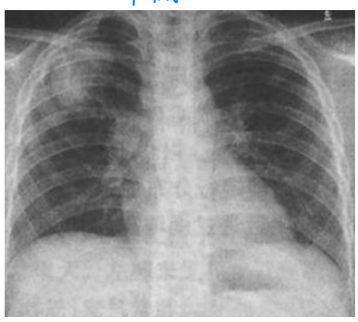


图 18-4 肺结核原发复合征模式图
右侧肺上叶下部胸膜下见黄白色原发病灶，肺门部见肿大的淋巴结，二者之间以淋巴管炎相连。





社区获得性肺炎有很多感染途径就是没有淋巴感染,结核的淋巴管炎只是播散方式,不是从这里感染过来的

2.抓住继发性肺结核的**多形性**改变

浸润性肺结核:薄壁空洞
干酪性肺炎:无壁虫蚀样空洞
慢纤空:厚壁空洞

（1）活动性病变的影像学表现

①渗出：边缘不清、密度不均的云雾状/云絮状影，呈斑点、斑片、实变等 eg.浸润性肺结核

②空洞：无壁、薄壁、厚壁，多无液平

③播散 沿支气管

VS 肺脓肿:有液平

（2）局限、修复的影像学表现

①钙化：边缘清楚、高密度、斑点、结节状(硬结)

②纤维化/条索：边缘清楚、密度增高(硬结)

就算出现钙化、纤维条索,但只要看到渗出、空洞、播散就一定是活动性病变

（二）结核菌素试验（PPD/OT）

1.患者感染结核杆菌的 **4-8 周后**产生致敏 **T 淋巴细胞**，当皮肤再次接触到结核杆菌抗原就可出现皮肤**IV型迟发型**变态反应。PPD 阳性与结核杆菌细胞壁的蛋白质所引起的变态反应相关

2.PPD 检出是否感染结核杆菌，并**非**用于检出是否为结核病 感染结核杆菌不等于结核病

①PPD 是常规检查，但对提示结核病的价值有限（小墓碑选项）受卡介苗、过去感染TB影响

②PPD 阳性对提示 ttsx 婴幼儿、儿童结核病价值较大，特别是**未接种卡介苗的婴幼儿**

③PPD 常呈**阴性**或弱阳性的情况：长期用糖皮质激素或免疫抑制剂、癌症、严重细菌感染、粟粒性结核、麻疹、水痘、HIV、结核性脑膜炎、营养不良（苏一爱洗礼、麻豆爱挠痒）

艾滋病

（三）确诊肺结核——痰结核杆菌检查 结核杆菌痰培养慢

1.**痰涂片（确诊首选）**VS 肺炎:痰培养首选(准确率高)

①痰含菌量＞5000-10000 个**抗酸杆菌**/ml 为阳性

②痰涂片是确定肺结核是否为**传染源**的依据：若**痰涂片阳性（涂阳）**——**开放性**肺结核（**排菌量大**），因此治愈涂阳肺结核是降低肺结核传染最重要的措施

排菌量到达一定量级才会传染

VS 病理学开放性肺结核:慢纤空